Diagnóstico de las disneas laríngeas del adulto

F Bories
JP Bessede
M Enaux

Resumen. – Una disnea se define como «la percepción consciente de una dificultad respiratoria». Se traduce para el paciente por una sensación subjetiva de aumento del trabajo respiratorio. Para el médico, se caracteriza por signos objetivos que le permiten verificar su realidad y definir su origen.
La disnea laríngea es una disnea obstructiva, a nivel laríngeo posterior a un obstáculo funcional o anatómico, intrínseco o extrínseco.
La laringe del adulto es más ancha que la del niño. Un aumento del grosor de la mucosa de 1 mm en el nivel cricoideo (la zona más estrecha y no extensible) reducirá el calibre de la vía respiratoria un 50 % en el niño y sólo un 20 % en el adulto. La disnea laríngea aguda es, por lo tanto, menos frecuente en el adulto que en el niño, pero resulta necesario reconocerla, apreciar su gravedad y organizar un tratamiento eficaz ante el riesgo ocasional de compromiso del pronóstico vital por hipoxia. La disnea laríngea crónica, de instauración progresiva, es mucho más frecuente en el adulto, la urgencia terapéutica es mínima y el problema es esencialmente etiológico.

© 2000, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Diagnóstico positivo

RESEÑAS FISIOPATOLÓGICAS

Durante la inspiración normal, existe una depresión relativa en el interior de las vías respiratorias extratorácicas que comporta una disminución de su calibre. La resistencia ofrecida al paso de un fluido en un conducto es proporcional a la cuarta potencia de su radio (ley de Poiseuille). Así, todo estrechamiento en el nivel laríngeo aumentará la resistencia al paso de aire de forma importante.

En caso de obstáculo laríngeo, la depresión endotorácica inspiratoria fisiológica debe acentuarse con el fin de permitir al aire penetrar a un ritmo constante en la región laríngea estrecha.

Resulta necesario amputar dos tercios del calibre útil de las vías respiratorias para que aparezcan las dificultades que provoquen un aumento del trabajo respiratorio.

La acentuación de la depresión endotorácica se debe al trabajo activo de los músculos respiratorios principales (diafragma e intercostales) y accesorios (esternocleidomastoideos, escalenos, pectorales mayores y menores, serratos mayores, dorsales anchos).

Si el aumento de la depresión endotorácica no basta para obtener un flujo inspiratorio suficiente, ésta debe durar más tiempo para obtener el mismo volumen de aire inspirado: la disnea inspiratoria se convierte en una bradipnea inspiratoria por alargamiento del tiempo inspiratorio de la respiración.

ASPECTOS CLÍNICOS

La disnea de origen laríngeo es, en su forma típica, una bradipnea inspiratoria. El ritmo de la ventilación se hace más lento esencialmente por alargamiento del tiempo de la inspiración (la frecuencia respiratoria normal del adulto se sitúa alrededor de 20 por minuto). La respiración se hace activa por la participación de los músculos respiratorios accesorios. La depresión intratorácica, más importante que para una inspiración normal, se acompaña de una depresión de las partes blandas en el nivel supraclavicular e intercostal en el adulto: se produce el tiraje.

La disnea de origen laríngeo se traduce también por la presencia de ruidos laríngeos que aparecen en el tiempo inspiratorio de la respiración, que son el estridor y el cornaje.

François Bories : *Chef de clinique-assistant.*
Jean-Pierre Bessede : *Professeur des Universités, ORL des Hôpitaux.*
Mathieux Enaux : *Chef de clinique-assistant.*
Service d'ORL, centre hospitalier universitaire Dupuytren, 2, avenue Martin-Luther-King, 87042 Limoges cedex.

El estridor es un ruido agudo análogo al que se produce soplando en un tubo estrecho en un punto, y traduce una disminución de permeabilidad en el nivel vestibular o glótico.

El cornaje es un ruido de tonalidad más grave, más sordo, ronco y cavernoso, comparable al obtenido soplando en un cuerno; traduce un estrechamiento glotosubglótico.

La bradipnea inspiratoria, el tiraje, el estridor y el cornaje caracterizan clínicamente la disnea de origen laríngeo. Pero pueden aparecer otros síntomas asociados, tales como la tos, las modificaciones de la voz (disfonía con voz ronca en caso de lesión del plano glótico y voz ahogada y cubierta en las lesiones supraglóticas), o incluso una disfagia o una odinofagia.

Diagnósticos diferenciales de las disneas laríngeas

Muchas afecciones extralaríngeas pueden ser disneizantes. Esta disnea tiene, según su origen, una expresión clínica a menudo diferente a la de la disnea laríngea.

■ *Disneas de origen cardíaco o pulmonar*

Se caracterizan por una taquipnea (o polipnea) que se define por un aumento de la frecuencia respiratoria por disminución de la duración del ciclo ventilatorio. Es una taquipnea de los dos tiempos respiratorios sin tiraje, cornaje ni estridor. La voz y la tos son normales.

■ *Disneas asmatiformes*

Son bradipneas espiratorias (el ritmo respiratorio es más lento por alargamiento del tiempo espiratorio) que se acompañan de una sibilancia espiratoria característica y de signos auscultatorios pulmonares.

■ *Disneas de origen traqueobronquial*

Afectan a los dos tiempos de la respiración y se acompañan de un «wheezing» (silibancia espiratoria o inspiratoria, que, focalizada y fija, traduce una estenosis) y de tos. La voz es, en sí misma, normal.

■ *Disneas obstructivas supralaríngeas*

Producen también una disnea inspiratoria, pero el tiraje es más alto en la región submandibular. La ventilación se mejora por la abertura bucal cuando el obstáculo es nasal o rinofaríngeo, o por la luxación de la mandíbula y la colocación de una sonda rinofaríngea cuando el obstáculo se sitúa en la faringe o en la base de la lengua. De todas maneras, el examen rinológico y bucofaríngeo permite el diagnóstico.

■ *Disneas de origen metabólico y neurológico central*

Aunque aparecen en un contexto distinto, constituyen un error clásico a veces difícil de evitar.

Diagnóstico de gravedad

Concierne esencialmente a las disneas laríngeas agudas. Las disneas laríngeas crónicas plantean sobre todo un problema etiológico. La urgencia terapéutica es mínima, excepto en caso de agravamiento brutal o de descompensación por patología sobreañadida.

El diagnóstico de gravedad permite adaptar el tratamiento y apreciar la necesidad o no de realizar de forma inmediata o diferida los gestos que permitan restablecer la vía aérea.

La gravedad de la disnea laríngea puede ser apreciada sobre:

— la duración (el umbral de gravedad se sitúa más allá de una hora en caso de disnea aguda) y la intensidad de la bradipnea; pero no hay que descuidar la gravedad de una polipnea superficial ineficaz o de una bradipnea extrema, irregular, eventualmente con pausas respiratorias;

— la intensidad del tiraje supraclavicular e intercostal: es proporcional a la importancia de la depresión intratorácica; pero resulta necesario recordar la gravedad de un tiraje bajo o nulo señalando el agotamiento del paciente;

— el comportamiento y el aspecto clínico del sujeto: el paciente puede estar tranquilo o, al contrario, agitado y angustiado, agotado al máximo: resulta entonces necesario saber reconocer la gravedad de una palidez intensa y de una cianosis que evidencia una hipoxia severa; los sudores dan cuenta de una hipercapnia;

— los datos hemodinámicos como el pulso, la tensión arterial y la existencia de signos cardiacos derechos; los signos de gravedad son taquicardia, hipertensión arterial, ingurgitación yugular y hepatomegalia dolorosa. Cualquiera que sea el estado inicial del paciente, el riesgo de agravamiento brusco de la disnea es siempre posible y justifica un tratamiento rápido y una supervisión estrecha. Los diferentes datos del examen clínico, frecuencia cardíaca, coloración, pulso y tensión arterial, deben ser apreciados de forma escrupulosa y controlados regularmente durante la evolución bajo tratamiento.

En algunos casos de extrema gravedad, el estado de asfixia es inminente. La respiración resulta superficial e ineficaz. El tiraje es débil o nulo, con señal de agotamiento. El pulso y la tensión arterial muestran tendencia a disminuir considerablemente. En ausencia de una intubación traqueal inmediata, o incluso de una traqueotomía, la evolución es rápidamente fatal.

Puede indicarse la intubación traqueal de forma diferida en caso de fracaso del tratamiento médico. La traqueotomía está indicada en los casos donde la intubación es imposible o inadaptada.

Diagnóstico etiológico

La anamnesis y el examen clínico del paciente permiten en numerosos casos una aproximación precisa al diagnóstico etiológico. El examen clínico y, en particular, el laríngeo se reducen siempre al mínimo estricto durante la fase disneica y mientras que el tratamiento no haya sido eficaz, con el fin de evitar todo agravamiento de la disnea.

Los datos de la anamnesis son fundamentales en la búsqueda etiológica; el contexto particular, por ejemplo, que sea infeccioso o traumático, la instauración brutal o progresiva de la disnea, los antecedentes o la advertencia de una disfonía o de una disfagia previa son todos ellos elementos de orientación diagnóstica.

El interrogatorio del entorno del paciente es, a menudo, de gran ayuda cuando no es posible la entrevista con el propio paciente.

El examen laríngeo con el fibroscopio flexible (nasofibroscopia) o con espejos y exámenes no invasivos, realizados después de una simple anestesia local permiten un examen anatómico laríngeo eficaz y un estudio dinámico de la función laríngea durante la respiración y la fonación.

La laringoscopia directa de suspensión, bajo anestesia general (en ventilación espontánea o en *jet-ventilation*), completada por la utilización de ópticas rígidas de angulaciones variadas (0°, 30°, 70°) y del microscopio quirúrgico, sigue siendo el medio más eficaz de exploración de la patología orgánica o traumática de la laringe. Permite un análisis lesional muy preciso del conjunto de las estructuras laríngeas y las tomas de

biopsias. Asociada a veces a un gesto terapéutico, desemboca en algunos casos en una traqueotomía. El momento en que debe procederse a la laringoscopia depende de la etiología de la disnea. Debe ser propuesta desde un principio en caso de cuerpo extraño, de traumatismo, de estenosis glotosubglótica o de etiología tumoral obstructiva, y estar precedida de un tratamiento médico bien conducido en otras etiologías. Otros exámenes complementarios, en particular radiológicos, raramente resultan útiles en primera intención y no deben en ningún caso retrasar el tratamiento.

Por orden decreciente de frecuencia, describiremos las causas tumorales, funcionales y neurológicas, las causas inflamatorias e infecciosas, las causas traumáticas de las disneas laríngeas y, finalmente, abordaremos el problema de la aspiración de cuerpos extraños, rara en el adulto.

DISNEA LARÍNGEA DE ETIOLOGÍA TUMORAL

Se trata esencialmente de cánceres de laringe y de hipofaringe y también, mucho más raramente, de tumores benignos de la laringe.

Disnea maligna

Los carcinomas escamosos constituyen la gran mayoría de los cánceres de laringe e hipofaringe. Se observan esencialmente en hombres entre 45 y 70 años. Los factores de predisposición son, ante todo, el tabaco para el cáncer de laringe, asociado al alcohol para el cáncer de hipofaringe.

El signo funcional que lleva al descubrimiento de un cáncer de laringe es la presencia en grados diversos de disfonía, de una disfagia o disnea.

Aunque la disnea es generalmente tardía, en algunos casos puede aparecer en primer plano durante la visita médica de los pacientes que acuden a consulta con retraso, y en el 10 % de los cánceres de laringe se necesita una traqueotomía o un gesto de desobstrucción laríngea en el momento del primer examen.

Ya se trate de tumores de la epilaringe, de la supraglotis (vestíbulo, ventrículo) o del plano glótico, la disnea laríngea indica una extensión tumoral importante. Al contrario, los cánceres infraglóticos (entre 1 y 3 % de los cánceres de laringe) evolucionan con escasas manifestaciones sin disfonía, y generalmente aparece en primer plano una disnea progresiva.

Los cánceres extendidos a dos o tres niveles son aquellos en los que la disnea puede necesitar una desobstrucción o una traqueotomía desde un principio.

Para los cánceres de hipofaringe, el primer síntoma que se encuentra es la disfagia. A menudo desde el primer examen aparece una adenopatía cervical. La disfonía traduce una lesión de la movilidad de las cuerdas por invasión de la pared faringolaríngea. La presencia de una disnea traduce la extensión tumoral completa a las estructuras laríngeas de un tumor muy avanzado.

El diagnóstico etiológico de la disnea es, a menudo, fácil cuando se asocian un terreno propicio y una historia clínica típica. Se basa en el examen clínico ORL y en laringoscopia directa bajo anestesia general, durante la cual la realización de tomas de biopsias para examen anatomopatológico permite certificar el diagnóstico. El diagnóstico por imágenes completará el análisis clínico y endoscópico. Sirve de ayuda en la decisión terapéutica cuyos métodos, en función de las indicaciones, pueden utilizar la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia.

Disnea benigna

Los tumores benignos de la laringe sólo raramente son causa de disneas laríngeas. No obstante, es necesario recordar cuatro tumores:

— *La papilomatosis laríngea del adulto* es el tumor benigno más frecuente en el plano glótico. El sexo masculino resulta afectado de forma predominante. El primer síntoma es la disfonía. Su carácter exuberante y desesperadamente reincidente, así como las complicaciones terapéuticas del tipo de sinequias y de estenosis, le confieren un potencial obstructivo que puede ser importante. La disnea, de instauración a menudo progresiva, es inicialmente de predominio nocturno, pero puede instalarse de forma brusca.

El diagnóstico se apoya esencialmente en el aspecto de las lesiones laríngeas en laringoscopia directa durante la cual la toma de biposias es indispensables. El tratamiento utiliza, sobre todo, la desobstrucción por medio del láser de CO_2 y la autovacunación [25].

— *Los tumores de Abrikossof* afectan al hombre en el 75 % de los casos. Se localizan preferentemente en los aritenoides y en el tercio posterior de las cuerdas vocales. Pueden adoptar un carácter infiltrante y obstructivo. El diagnóstico se basa en la endoscopia y el examen anatomopatológico. La exéresis por vía natural es a menudo suficiente [17].

— *El condroma del cricoides* es un tumor cartilaginoso que se desarrolla esencialmente en el hombre a partir de los 60 años (dos tercios de los casos). Asintomático durante largo tiempo, se manifiesta por una disnea de instauración progresiva por estenosis subglótica. El tratamiento es quirúrgico y asocia exéresis tumoral y calibración prolongada [17].

— *El laringocele* se desarrolla a partir del apéndice ventricular o sáculo del ventrículo de Morgagni. A menudo asintomático, puede revelarse en formas muy voluminosas por disfonía ligera, molestia faríngea y disnea moderada. La instauración de una disnea aguda en cuestión de horas es una complicación clásica, siempre grave, de un laringocele (en 22 de 139 casos para Stell [23]). Puede también ser la causa de accidentes mortales en inmersión submarina. El tratamiento quirúrgico puede ser realizado por vía endoscópica o por tirotomía.

DISNEAS LARÍNGEAS DE ORIGEN FUNCIONAL Y NEUROLÓGICO

Se trata de afecciones que alteran la movilidad de las cuerdas vocales. Las parálisis de las cuerdas vocales y los movimientos anormales de la laringe son los mecanismos neurológicos que provocan las disneas laríngeas. La laringe es un verdadero efector respiratorio. Se abre una fracción de segundo antes de la penetración del aire por el efecto del movimiento de descenso diafragmático. Este fenómeno, bajo la dependencia de los centros respiratorios medulares, es amplificado por la hipercapnia y la obstrucción. Se reduce por hiperventilación e hipocapnia [24].

Puede tratarse de disneas laríngeas intermitentes o permanentes.

Disneas laríngeas permanentes

Se trata de parálisis laríngeas en cierre. Sólo las afectaciones bilaterales, mucho menos frecuentes que las unilaterales, originan una disnea laríngea. La diplejía en cierre o parálisis en aducción es la forma más frecuente de las displejías laríngeas [18].

El principio puede ser brusco, con un cuadro asfixia que necesita una intubación o una traqueotomía urgente. Pero muy a menudo es progresivo, inicialmente con una disnea laríngea ligera y bien tolerada, eventualmente intensificada por el esfuerzo, la tos, la risa, una aspiración de alimentos o un episodio infeccioso. El inicio progresivo traduce la instauración por etapas de la diplejía: paresia que evoluciona en parálisis completa o parálisis unilateral que se transforma en bilateral.

El diagnóstico de las displejías laríngeas se basa en el examen laríngeo con fibroscopia o con óptica rígida, que permiten un estudio dinámico en inspiración y en fonación sin perturbar la movilidad laríngea.

La radiografía estándar y las tomografías de la laringe presentan la imagen clásica de llave inglesa invertida.

Cuadros clínicos

• *Parálisis de los dilatadores de la glotis o síndrome de Gerhardt*

El cuadro clínico comprende una voz casi normal que contrasta con una bradipnea inspiratoria. El examen con espejillo y la fibroscopia laríngea, realizados prudentemente ante el riesgo de espasmo laríngeo, presentan cuerdas vocales de aspecto normal en posición paramedial. La abertura glótica reducida permite un paso aéreo moderado. Las cuerdas vocales, que no tienen ningún movimiento de abducción durante la inspiración y mostrarían incluso tendencia a aproximarse, se enfrentan normalmente durante la fonación.

Existe un fondo de disnea persistente sobre el cual pueden aparecer accesos paroxísticos de disnea aguda con sofocación y compromiso del pronóstico vital.

• *Diplejía laríngea global o síndrome de Riegel*

La disnea inspiratoria se asocia en este caso a una disfonía importante. La parálisis es total, y no existe ningún movimiento de abducción o de aducción. El examen laríngeo encuentra las cuerdas vocales en posición paramedial totalmente inmóviles, incluso durante la fonación.

Puede ser difícil distinguir los síndromes de Gerhardt y de Riegel, en particular cuando la parálisis de los dilatadores se acompaña de una estenosis muy ceñida y la importancia de la disnea impide la fonación, y, al revés, cuando la movilidad pasiva de las cuerdas vocales en la inspiración puede imponerse por una parálisis de los dilatadores en las parálisis globales.

Etiologías

El origen de las displejías laríngeas puede ser central o periférico. La proximidad de los núcleos laringomotores derecho e izquierdo explica la lesión bilateral potencial de las etiologías centrales; el cuadro neurológico es, a menudo, complejo. Pero la diplejía laríngea puede ser también de origen cervical bajo, donde los dos nervios recurrentes están separados sólo por el eje visceral traqueoesofágico. Ya sea en aducción o en abducción, global o limitada a los dilatadores, la forma de la diplejía no es específica de una lesión topográfica precisa, incluso si se opone clásicamente el síndrome de Gerhardt de origen central al síndrome de Riegel de origen periférico. De hecho, en los dos síndromes se han encontrado alteraciones periféricas o centrales.

En el caso de la búsqueda etiológica, resulta de utilidad cierto número de exámenes:

— un examen neurológico completo;

— electromiografía laríngea que permite distinguir las afectaciones neurógenas y miógenas y evaluar la importancia;

— radiografía pulmonar, que se requiere de forma sistemática para investigar una afección de mediastino;

— en función de los elementos de orientación clínica, pueden proponerse: una panendoscopia ORL, una fibroscopia bronquial, una fibroscopia esofágica y un tránsito baritado esofágico, una exploración tiroidea por ecografía y gammagrafía, un escáner craneal, cervical y mediastinotorácico y un diagnóstico por imágenes por resonancia magnética (RM) de la fosa posterior.

• *Etiologías centrales*

— Lesiones agudas

Las causas virales son las más frecuentes, esencialmente en la forma de encefalitis virales. El cuadro neurológico es rico, aunque el descubrimiento del virus es difícil de obtener. La poliomielitis anterior aguda, en su forma bulbar, puede acarrear una parálisis global o limitada a los dilatadores.

Las causas anóxicas y vasculares por lesión bulbar son posibles en el curso de los comas tóxicos por barbitúricos, en los traumatizados craneales graves y en algunos accidentes quirúrgicos.

— Lesiones progresivas

La sífilis es considerada como causa principal de la parálisis de los abductores de la laringe, esencialmente en la tabes.

Las alteraciones degenerativas están esencialmente representadas por la esclerosis lateral amiotrófica, aunque la atrofia olivopontocerebelosa, la poliomielitis anterior crónica, la parálisis bulboprotuberancial y la esclerosis múltiple pueden ser causa de una diplejía laríngea.

La siringobulbia y el síndrome de Arnold-Chiari son también causas de diplejías laríngeas en cierre.

• *Etiologías periféricas*

Son esencialmente los traumatismos quirúrgicos y los tumores del eje visceral del cuello.

La cirugía tiroidea es la primera causa de diplejía laríngea en cierre, pero puede ser también producida por cirugías esofágicas, traqueales y torácicas.

Toda infiltración tumoral cervical baja o mediastinal alta puede ser causa de una diplejía laríngea.

La existencia de diplejías verdaderas secundarias a una intubación es aún objeto de debate [10].

■ *Disneas laríngeas intermitentes*

Espasmos laríngeos

Se trata de episodios intermitentes de cierre de la laringe excesiva e inadaptada, responsables de accesos de dificultad respiratoria sin disnea permanente.

Los espasmos laríngeos deben ser considerados como una entidad patológica. Su fisiopatología implica una exageración de los reflejos de cierre laríngeo, bien por aumento de las respuestas motoras o bien por descenso del umbral de desencadenamiento del reflejo.

Pueden ser primarios, apareciendo como respuesta a una irritación laríngea cuya etiología puede ser variada, como el reflujo gastroesofágico, una rinorrea posterior, aspiración de alimentos, aspiración de cuerpos extraños o de cáusticos o tos.

También se han descrito durante varias afecciones neurológicas: tabes, siringobulbia, enfermedad de Parkinson [26], accidentes vasculares en el territorio vertebrobasilar [15], síndromes seudobulbares, epilepsias, discinesias postneurolépticos. La conversión histérica es una causa clásica cuya frecuencia no debe sobreestimarse. Los espasmos laríngeos pueden también aparecer en el transcurso del tétanos y de la rabia.

El examen y las exploraciones complementarias permiten definir objetivamente el espasmo e investigar una etiología. La laringoscopia indirecta y la fibroscopia laríngea, completadas con la laringoscopia directa, el análisis foniátrico y la electromiografía laríngea, certifican el espasmo.

La búsqueda etiológica comprende un examen neurológico completo, un electroencefalograma, la exploración del tronco cerebral por RM y el conjunto de exámenes que pueden permitir el descubrimiento de un factor de irritación laríngea. El tratamiento se basa en la eliminación de la causa irritante o el tratamiento etiológico neurológico.

Inversión del movimiento laríngeo respiratorio

Se traduce por un movimiento de aducción de las cuerdas vocales en inspiración y de abducción en la espiración. El estridor es a menudo muy importante. La persistencia de movimientos normales de las cuerdas vocales durante la fonación permite evocar el diagnóstico.

Tal cuadro clínico puede formar parte de un mecanismo de conversión histérico, pero resulta necesario eliminar una afección orgánica.

Tratamiento

La disnea laríngea debida a alteraciones funcionales y neurológicas laríngeas, sea intermitente o permanente, hace correr un riesgo vital. Pueden proponerse diferentes tratamientos sintomáticos.

Ensanchamiento de la vía glótica [21, 22]

Las técnicas quirúrgicas clásicas son las aritenoidectomías y las aritenoidopexias por vía lateral o translaríngea. Se pueden realizar una aritenoidectomía o una cordectomía segmentaria posterior por medio del láser de CO_2 por vía endoscópica. Estas técnicas evitan la traqueotomía pero comprometen el resultado vocal. Su eficacia parece similar desde el punto de vista de la ventilación, pero la cordectomía es técnicamente más sencilla y produciría menos aspiraciones alimentarias secundarias [4].

Traqueotomía

No compromete la morfología glótica ni las posibilidades de recuperación vocal posterior. Puede utilizarse una cánula fonatoria.

- Los procesos de reinervación y las tentativas de creación de marcapasos laríngeos forman aún parte del terreno de la experimentación.
- Puede proponerse inyección de toxina botulínica en el tratamiento de los espasmos laríngeos y en la inversión de los movimientos laríngeos respiratorios.

DISNEAS LARÍNGEAS DE ETIOLOGÍA INFECCIOSA O INFLAMATORIA

Se trata de laringitis que se definen como inflamaciones de la mucosa laríngea.

Laringitis agudas disneizantes del adulto de etiología infecciosa

Aunque la laringitis catarral común se acompaña de una simple disfonía sin disnea, existen en el adulto formas graves de laringitis mucho más raras y disneizantes.

Epiglotitis del adulto

Denominada también laringitis supraglótica vestibular, la epiglotitis es rara en el adulto [5].

Es la forma la más grave de las laringitis agudas del adulto. El principal germen responsable es *Haemophilus influenzae* [2, 12], si bien aparentemente pueden intervenir otros gérmenes. Es una afección de predominio masculino (relación de 3/1) [14].

En un contexto infeccioso, se asocian al cuadro clínico dolor faríngeo y disfagia de instauración brutal, a veces con sialorrea. La disnea inspiratoria es a menudo de aparición tardía.

El mejor examen es la nasofibroscopia [16]. Permite establecer el diagnóstico mostrando una epiglotis edematosa con un eritema localizado o difuso y, en ocasiones, verdaderos acúmulos purulentos con microabscesos.

La hospitalización debe ser sistemática, a causa de una posible e imprevisible evolución hacia el empeoramiento. El tratamiento asocia una antibioterapia de amplio espectro por vía parenteral a la corticoterapia, que sigue siendo discutida. La intubación está indicada cuando aparecen signos de gravedad respiratoria y tanto más, cuanto más precoz fue la aparición de la disnea [2].

El diagnóstico precoz y un tratamiento más adecuado han permitido mejorar el pronóstico de forma espectacular. La mortalidad, que llegó a alcanzar el 32 % [8], es actualmente nula [5, 14].

Laringitis diftérica (crup laríngeo)

Hasta hoy era excepcional en el adulto pero aparentemente los casos de difteria están actualmente en franca recrudescencia. Debe considerarse el diagnóstico ante la existencia de una angina con seudomembranas. Las seudomembranas características en el nivel veloamigdalino se extienden hacia la laringe y son causa de obstrucción. Desde el punto de vista clínico, se observa clásicamente una reacción ganglionar importante, coriza mucosa o mucopurulenta y fiebre poco elevada. El concepto de contagio (incubación de 3 a 4 días) y la ausencia de vacunación son argumentos positivos. Toda sospecha de difteria impone toma de muestras de garganta en busca del bacilo de Klebs-Löffler en las seudomembranas, así como la administración de seroterapia y de antibioterapia (penicilina).

Laringitis gripal

Si en la mayoría de los casos se presenta bajo forma de una laringitis catarral banal, existen formas graves y disneizantes con alteraciones epiglóticas edematosas, ulcerosas y también flemonosas.

Tuberculosis laríngea

Se han descrito algunos casos aparecidos en forma de laringitis aguda disneizante [16]. La disnea de instauración progresiva que evidencia una forma muy avanzada y descuidada es hoy excepcional.

En el inmunodeprimido (aplasia, SIDA)

En este contexto, la laringitis aguda banal puede tomar un aspecto evolutivo preocupante y disneizante.

Laringitis disneizantes del adulto de etiología inflamatoria

Laringitis alérgicas

Pueden acarrear un edema laríngeo brutal y obstructivo. El contexto es a menudo revelador en presencia de signos atópicos conocidos y la noción de un factor desencadenante específico (picadura de insecto, ingestión alimenticia o medicamentosa etc.). La encuesta alergológica posterior servirá de ayuda al diagnóstico.

El tratamiento de la crisis se basa en la corticoterapia por vía parenteral y la terapia con aerosoles. La adrenalina está indicada en caso de choque asociado. Al evitar el alérgeno se impedirá la recidiva.

Edema angioneurótico

Es el edema clásico de Quincke. El edema angioneurótico hereditario es una entidad nosológica particular que puede revelarse por una laringitis edematosa brutal y que hay que saber evocar cuando no aparece ninguna etiología evidente. El diagnóstico se basa en el descubrimiento de un déficit en el inhibidor de la C1-esterasa que puede transmitirse de forma autosómica dominante o adquirirse en el marco de afecciones linfoproliferativas. El tratamiento del déficit en C1-esterasa se basa en la administración de derivados androgénicos que corrigen la carencia bioquímica y constituyen un tratamiento profiláctico.

Laringitis por aspiración de vapores cáusticos

El cloro, los óxidos de nitrógeno, el amoníaco, el fosgeno y los ácidos fluorhídrico y clorhídrico son los gases tóxicos más a menudo incriminados. Su aspiración a concentración moderada produce un edema por quemadura laríngea y disnea. El edema predomina generalmente al nivel de la epilaringe y del vestíbulo laríngeo; puede ser considerable y obstruir totalmente la vía.

Las circunstancias del accidente y el contexto casi siempre profesional facilitan el diagnóstico. El tratamiento depende del estado del sujeto: tratamiento antibiotico y corticoideo en caso de edema moderado que regresa habitualmente en menos de 72 horas; intubación y medidas de reanimación intensiva cuando el estado es alarmante.

El pronóstico está relacionado principalmente con la lesión pulmonar eventual concomitante.

DISNEAS LARÍNGEAS DE ORIGEN TRAUMÁTICO

Los traumatismos externos de la laringe pueden provocar disneas laríngeas agudas. Las estenosis laríngeas son secuelares, postraumáticas y de naturaleza cicatrizal; originan disneas de evolución crónica.

Traumatismos externos de la laringe

Aparecen sobre todo en accidentes de tráfico [3, 6, 19]: en particular, accidentes de automóvil con choque frontal y traumatismo laríngeo. Las tentativas de autólisis por ahorcamiento y los accidentes deportivos (deportes de combate) son también causas clásicas de traumatismos laríngeos.

Las lesiones pueden ser de naturaleza e importancia variable: conmoción, contusiones, rupturas ligamentosas o musculares, fracturas, luxaciones e incluso desinserciones laringotraqueales.

Si existe en general siempre disfonía, la disnea es inconstante y condiciona la actitud que se ha de adoptar.

La conmoción laríngea inicial puede acarrear una disnea inmediata por mecanismo reflejo que, por regla general, cede rápidamente.

La disnea puede aparecer secundariamente, después de un intervalo libre, sobre una contusión o una fractura por constitución de un edema, y justifica una supervisión sistemática durante 48 horas, en medio hospitalario, de toda persona con traumatismo laríngeo.

Las fracturas laríngeas múltiples y las desinserciones laringotraqueales pueden provocar un estado de asfixia inmediata que necesita un gesto de restablecimiento urgente de la vía aérea.

El origen de la disnea no plantea problema si el concepto de traumatismo laríngeo es evidente. El traumatismo laríngeo de escasa relevancia pasa al segundo plano y no es diagnosticado más que secundariamente en el politraumatizado.

El examen clínico busca lesiones cutáneas cervicales: excoriaciones, equimosis, hematomas, edemas o tumefacción cervical y existencia de un enfisema subcutáneo. El examen laríngeo, cuando resulta posible, aprecia el estrechamiento de la vía aérea y la movilidad de las cuerdas vocales, y permite un primer análisis de las lesiones.

La laringotraqueoscopia bajo anestesia general, eventualmente cubierta por una traqueotomía previa, estudia precisamente las lesiones endolaríngeas: luxaciones cricoaritenoideas, desgarros mucosos, desinserción del pie de la epiglotis, hundimientos cartilaginosos. Se asocia sistemáticamente una hipofaringoesofagoscopia para investigar las lesiones asociadas.

El examen tomográfico laríngeo tiene gran interés, ya que permite una definición exacta de las lesiones [13, 20] y ayuda a la decisión quirúrgica cuando no es evidente. Por desgracia, rara vez se puede realizar en primera intención y su indicación debe tener en cuenta el grado de urgencia y la importancia de los signos funcionales. Por tanto, se lleva a cabo muy frecuentemente en segunda instancia.

El tratamiento depende del estado local y general del herido. Una disnea importante asociada a la presencia de un enfisema subcutáneo y de dolores sensibles a la palpación impone la traqueotomía, una evaluación endoscópica y un tratamiento quirúrgico rápido. Cuando el estado del sujeto no es preocupante de inmediato, en el curso de un traumatismo de importancia moderada, la presencia de un enfisema subcutáneo, que señala la abertura de las vías aéreas, constituye una indicación quirúrgica, según la mayoría de los autores [3, 7], precedida eventualmente de un análisis escanográfico. La presencia de una simple contusión asociada a un edema poco obstructivo justifica un tratamiento antibiótico y corticoideo y una supervisión cuidadosa.

Estenosis laríngeas

Se define como una disminución de calibre progresivo y persistente de la vía laríngea como consecuencia de una alteración orgánica de las paredes laríngeas por un tejido de neoformación habitualmente fibroso. En el adulto, se trata de estenosis cicatrizales adquiridas, esencialmente después de traumatismos externos, o sobre todo internos, iatrogénicos. Toda ulceración mucosa y cualquier denudación cartilaginosa comportan la formación de un tejido granulomatoso que evoluciona más fácilmente hacia una cicatriz fibrosa, eventualmente estenosante, cuando existe sobreinfección.

Las estenosis graves resultan de una lesión del esqueleto cartilaginoso laríngeo. Las lesiones aisladas de la mucosa, aunque pueden originar a cicatrices retráctiles, producen habitualmente estenosis menores de tratamiento más fácil. La lesión cartilaginosa puede ser primaria, durante traumatismos externos, o secundaria a traumatismos internos.

Si los traumatismos externos pueden desembocar en estenosis laríngeas de naturaleza y gravedad muy variables, las lesiones debidas a traumatismos internos están más sistematizadas y conciernen esencialmente a la parte posterior de la laringe y la subglotis.

Etiologías de las estenosis

Los traumatismos internos iatrogénicos constituyen actualmente cerca del 90 % de las etiologías de las estenosis laríngeas [11]. Son esencialmente estenosis como secuelas de los cuidados intensivos, que se han desarrollado considerablemente. Las estenosis están directamente relacionadas con la intubación traqueal prolongada, la traqueotomía o su asociación para asistencia ventilatoria. Son particularmente frecuentes después de comas de origen neurológico y, también, tras descompensaciones respiratorias, infecciones agudas graves y en casos de cuidados intensivos postoperatorios. Como otras causas yatrogénicas, se pueden implicar los actos quirúrgicos en el nivel laríngeo.

Entre las causas directas predominan los traumatismos externos, ya sean cerrados o abiertos. Se pueden también considerar etiologías más raras: estenosis secundarias a quemaduras laríngeas o por infiltración en el caso de enfermedades infecciosas (difteria, sarampión, viruela, tifus, sífilis, esclerosis, lepra), o afecciones raras (enfermedad de Wegener, amiloidosis, enfermedad de Sutton, policondritis crónica atrofiante, dermatitis ampollosa con microsinequias y atrófica, enfermedad de Launois-Bensaude).

Diagnóstico

El interrogatorio permite trazar la historia clínica precisando la fecha y la naturaleza de un accidente ocasional o la duración de una estancia en cuidados intensivos. El examen cervical busca cicatrices cutáneas secuelares, quirúrgicas o traumáticas.

El examen laríngeo en consulta permite un primer análisis de las lesiones y un estudio dinámico de la función laríngea.

El análisis paraclínico comprende [1, 11] en primer lugar una exploración endoscópica indispensable para apreciar las lesiones y su evolución. Es posible diferenciar entre estenosis simples (aritenoideas, cricoideas, glóticas, vestibulares), escalonadas (cricoaritenoideas, cricotraqueales, cricoaritenotraqueales, aritenotraqueales) y complejas, que escapan a cualquier sistematización [9]. Las exploraciones funcionales respiratorias definen objetivamente y cuantifican la consecuencia de la estenosis sobre la función ventilatoria. El análisis radiológico (escáner) precisa la localización y la extensión de las lesiones.

Tratamiento

El tratamiento endoscópico utiliza las dilataciones y la microcirugía laríngea donde se aplica el láser.

Entre los tratamientos quirúrgicos predominan las técnicas de resección-anastomosis y las intervenciones de ampliación.

DISNEAS LARÍNGEAS POR ASPIRACIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS

Es un accidente raro en el adulto. En la mayoría de los casos se trata de aspiraciones alimentarias, y el diagnóstico no se presta a confusión.

Un cuerpo extraño laríngeo puede acarrear un cuadro de asfixia rápidamente fatal si obstruye totalmente la vía respiratoria. Pero, muy a menudo, el cuerpo extraño se enclava en el nivel laríngeo permitiendo el mantenimiento de una ventilación. El cuadro clínico asocia entonces una disnea laríngea continua con accesos de sofocación y una voz apagada. El cuerpo extraño puede permanecer móvil en la tráquea después de haber superado el obstáculo laríngeo y acarrear, favorecido por los cambios de posición, una disnea a veces laríngea y a veces espiratoria. Después de un esfuerzo de tos, puede también enclavarse seguidamente en la infraglotis y producir una obstrucción completa. Ello explica la particular peligrosidad de los cuerpos extraños móviles traqueales.

El tratamiento depende del grado de urgencia y de los medios de que se disponga. En situación de extrema urgencia ante una disnea laríngea amenazante, se puede intentar la maniobra de Heimlich. La extracción de un cuerpo extraño enclavado en el nivel laríngeo puede a veces llevarse a cabo con un simple laringoscopio y una pinza de Magill. Cuando la extracción es imposible, se puede empujar el cuerpo extraño a un bronquio principal con una sonda de intubación, con el fin de permitir la ventilación sobre un pulmón. Se impone una traqueotomía, o en su defecto la punción traqueal con un trocar de calibre suficiente, cuando aparecen signos de gravedad y es imposible la extracción. Aparte de las situaciones de extrema urgencia, el tratamiento se resume en una laringotraqueobroncoscopia, que confirma el diagnóstico y permite la extracción del o de los cuerpos extraños. Ésta debe ser realizada lo más pronto posible cuando existe una disnea o se advierte un cuerpo extraño móvil particularmente peligroso.

Conclusión

El diagnóstico de una disnea laríngea pasa inicialmente por el reconocimiento clínico de la localización laríngea del obstáculo respiratorio. Siempre, en primer lugar, hay que apreciar la gravedad. Aunque las causas sean múltiples, en muchos casos la anamnesis y el examen clínico permiten una orientación etiológica. Si el examen de la laringe es ahora muy eficaz gracias a la utilización de medios ópticos, la laringoscopia directa bajo anestesia general, sigue siendo, en muchos casos, el examen clave para confirmar el diagnóstico etiológico, realizar el análisis lesional preciso y proponer y llevar a cabo el procedimiento terapéutico.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Bories F, Bessede JP et Enaux M. Diagnostic des dyspnées laryngées de l'adulte. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-643-A-10, 1996, 6 p.

Bibliografía

[1] **BOUCHE J, RIU R, FLOTTE SL, DEJEAN Y, LEDEN R, FRECHE CH.** Les traumatismes du larynx et leurs séquelles. Rapport de la Société française d'ORL et de pathologie cervicofaciale. Arnette. Paris. **1970**

[2] **DEEB ZE, YEUSON AC, DEFRIES HO.** Acute epiglottitis in the adults. Laryngoscope **1985** ; 95 : 289-291

[3] **DEHESDIN D, FOUIN M, ANDRIEU-GUITRANCOURT J.** Les traumatismes laryngés externes récents. Attitude thérapeutique. Cah ORL **1985** ; 20 : 627-632

[4] **ECKEL HE, THUMFART M, WASSERMANN K, VÖSSING M, THUMFART WF.** Cordectomy versus arytenoïdectomy in the management of bilateral vocal cord paralysis. Ann Otol Rhinol Laryngol **1994** ; 103 : 852-857

[5] **FRIEDMAN M, TORIUMI DM, GRYBAUSKAS V, APPELBAUM EL.** Epiglottite de l'adulte. Proposition d'une classification clinique et d'une stratégie thérapeutique. Ann Otolaryngol Chir Cervicofac **1989** ; 106 : 406-409

[6] **GARAND G, LOCICIRO CL, DIOP EM, ROBIER A, REYNAUD J.** Problèmes posés par les traumatismes externes fermés du larynx. Rev Laryngol **1981** ; 102 : 425-436

[7] **GUERRIER Y, DEJEAN Y, GUERRIER B.** Traumatismes externes du larynx. A propos de notre expérience personnelle. J Fr ORL **1978** ; 27 : 633-641

[8] **HAWKINS DB, MILLER AH, SACHS GB et al.** Acute epiglottitis in adults. Laryngoscope **1973** ; 83 : 1211-1220

[9] **LACCOURREYE H, BEUTTER P, BRASNU D.** Sténoses laryngées et laryngotrachéales de l'adulte. Classification. Traitement. Ann Otolaryngol Chir Cervicofac **1984** ; 101 : 253-259

[10] **LACCOURREYE H, CHABOLLE F, BRASNU D, LACAU SAINT-GUILY J.** Les immobilités laryngées après intubation. Ann Otolaryngol **1984** ; 101 : 253-259

[11] **LACCOURREYE H, PECH A, PIQUET JJ et coll.** Les sténoses laryngotrachéales de l'adulte et de l'enfant. Rapport de la Société française d'ORL et de pathologie cervicofaciale. Arnette. Paris. **1985**

[12] **LISSAC J, TENAILLON A, LABROUSSE J et coll.** Les épiglottites aiguës de l'adulte. Trois observations et revue de la littérature. Ann Med Interne **1980** ; 131 : 231-234

[13] **MACERI DR, MANCUSO AA, CANALIS RF.** Value of computed axial tomography in severe laryngeal injury. Arch Otolaryngol **1982** ; 108 : 449-451

[14] **NAUDO P, LIEVRE G, GILAIN L, PEYNEGRE R.** L'épiglottite de l'adulte. J Fr ORL **1993** ; 42 : 145-148

[15] **PENDER DJ.** Laryngismus fugax : transient laryngeal spasm secondary to brain stem ischemia. Laryngoscope **1984** ; 94 : 1497-1500

[16] **PERRIN A, HAREUX S, FLORANT A, BARIL CH, DEPONOT J., ROULEAU P.** Dyspnées laryngées de l'adulte d'origine infectieuse. A propos de 54 cas. Ann Otolaryngol **1987** ; 104 : 625-631

[17] **PIQUET JJ.** Les tumeurs bénignes du larynx. **Encycl Med Chir** (Elsevier, Paris), Otorhinolaryngologie. 20700 A[10]. **1985** ; 6 p

[18] **PIQUET JJ, MARTIAT B, BERRIER A, TON VAN J, VANHAU-DENARDE JM, DARRAS JA.** Les immobilités laryngées bilatérales en fermeture. Aspects étiologique, clinique et thérapeutique. 83e Congrès de la Société française d'ORL. Paris. Septembre 1986. Compte rendu des séances. Arnette. Paris. **1987** ; pp 401-406

[19] **ROUX O, JUNIEN-LAVILLAUROY C.** Conduite à tenir devant un traumatisme du larynx. A propos de 25 cas. J Fr ORL **1981** ; 30 : 169-178

[20] **SCHAEFER SD, BROWN OE.** Selective application of CT in the management of laryngeal trauma. Laryngoscope **1983** ; 93 : 1473-1475

[21] **SESSION DG, OGURA JH, HEENEMAN H.** Surgical management of bilateral cord paralysis. Laryngoscope **1976** ; 86 : 559-566

[22] **SINGER MI, HAMAKER RC, MILLER SM.** Restauration of the air way following bilateral recurrent laryngeal nerve paralysis. Laryngoscope **1985** ; 95 : 1204-1207

[23] **STELL PM, MARAN AG.** Laryngocèle. J Laryngol Otol **1975** ; 89 : 915-925

[24] **SUSUKI M, KIRSCHNER JA.** The posterieur cricoarytenoïd as an inspiratory muscle. Ann Otol **1969** ; 78 : 849-863

[25] **TRAISSAC L.** Papillomatose laryngée. **Encycl Med Chir** (Elsevier, Paris). Otorhinolaryngologie. 20700 A[10]. **1992** ; 8 p

[26] **VAS CJ, PARSONAGE M, LORD OC.** Parkinsonism associated with laryngeal spasm. J Neurol Neurosurg Psychiatry **1965** ; 22 : 401-403